

23 - 01- La Prématurité - Pr. N. El Idrissi Slitine

Bonjour, nous allons présenter le cours sur la prématurité. Comment se définit la prématurité ? Le prématuré est un enfant né avant 37 semaines d'âge gestationnel, soit avant le 259ème jour, depuis le premier jour des dernières règles. On a trois catégories de prématurés.

La prématurité modérée, ce sont les nouveaux-nés qui sont nés entre la 32ème et la 36ème semaine, 6-7ème d'âge gestationnel. Il y a la grande prématurité, les bébés qui sont nés en 66 et 31, 6-7ème d'âge gestationnel. Et puis, il y a l'extrême prématurité, ce sont les nouveaux-nés qui sont nés entre 22 et la 25ème semaine, 6-7ème d'âge gestationnel.

La prématurité peut être soit isolée ou associée à une hypotrophie. Nous avons également une définition basée sur le poids de naissance. Le faible poids de naissance, les bébés qui sont nés à moins de 2500 grammes, les très faibles poids de naissance, les bébés nés à moins de 1500 grammes et les extrêmes faibles poids de naissance, les bébés qui sont nés à moins de 1000 grammes.

Concernant les écologies de la prématurité, ils sont connus dans 60% des cas. Il y a des facteurs obstétricaux, tels que les grossesses multiples, tels que le placenta praevia et les malformations utérines ainsi que les béances cervicales. Il y a les facteurs maternels, tels que le diabète, la toxémie gravidique, la low immunisation et les infections.

Des causes fœtales, tels que les malformations chromosomiques, les infections fœtales, les malformations congénitales. Des facteurs socio-économiques, tels que la multiparité, les conditions défavorables du travail, l'âge maternel soit inférieur à 18 ans ou plus de 35 ans, une taille maternelle inférieure à 1m50, un poids inférieur à 45 kg ou bien des intervalles entre les grossesses à moins de 1 an ou de plus de 10 ans. Toute prématurité y expliquée doit être considérée comme une infection jusqu'à preuve de vie.

Il y a également la prématurité iatrogène provoquée. Quand on extrait le bébé, soit pour sauver la maman ou pour le sauver lui-même, ça s'appelle une prématurité iatrogène et c'est dans les cas de césarienne pour souffrance fœtale aiguë, pour pré-éclampsie ou pour hématome rétro-placentaire. Concernant le diagnostic clinique, le diagnostic de la prématurité peut se faire de plusieurs façons. D'abord, avant la naissance, La datation de l'âge gestationnel peut se faire soit à partir de la dernière date des règles, à condition que le cycle soit régulier, à travers l'échographie du premier trimestre entre la 12e et la 14e semaine améliorée, et c'est la datation la plus précise, à travers la courbe thermique de la parturiente ou en connaissant le jour exact secondant, dans l'aide à la procréation médicale par exemple.

Après la naissance, il y a des scores qui sont utilisés pour évaluer l'âge gestationnel. Les plus utilisés sont le score de Phare et le score de Bala qui vont s'appuyer sur un simple examen clinique. Le score de Phare se compose de plusieurs items, ainsi que de nombres allant de 0 à 4.

0 pour ce qui concerne la grande prématurité et 4 pour tout ce qui s'approche du terme.

Concernant la peau, on va s'intéresser à la couleur, à la transparence de la peau, à la texture de la peau. Ensuite, nous avons un item qui parle des œdèmes, des extrémités. Nous avons également le lanugo.

Le lanugo, c'est le duvet qu'on retrouve chez les nouveaux-nés qui sont nés plus prématurés. Nous avons également d'autres items tels que le tissu mammaire, le module mamelonnaire, les plis plantaires qui sont absents en présence d'une grande prématurité. Et puis, on retrouve des indentations profondes sur toute la plante quand le bébé est à terme.

On s'intéresse également aux oreilles, à leur forme, à leur fermeté. Chez les nouveaux-nés à terme, les oreilles sont bien formées, elles sont fermes. Et puis, pour les organes génitaux externes, il y a des particularités.

Chez le sexe masculin, les testicules sont bien descendus dans leur scrotum chez le bébé qui est à terme. Et puis, les grandes lèvres sont bord à bord chez la petite fille à terme. Après avoir vu tous les items, ça nous permet à la fin d'établir un score.

Nous prenons par exemple le score de sept qui correspond à 29 semaines d'âge gestationnel. Ça nous permet de faire une datation de ce bébé qui est né et dont on ne connaît pas exactement l'âge gestationnel. En plus du score de fin, nous avons aussi le score de valeur qui s'intéresse en plus de la maturité physique à la maturité neuromusculaire qui étudie donc la posture, le retour en flexion, l'angle poplité, le signe du foulard et le signe talon-oreille.

Quand on a fini d'établir l'âge gestationnel à travers ces scores, nous devons obligatoirement toujours évaluer l'existence d'un retard de croissance intra-hétéra associé et cela ne peut pas se passer des courbes anthropométriques. Nous devons mettre les bébés qu'on a datés sur les courbes poids, périmètre crânien et taille. D'autres moyens sont possibles pour dater l'âge gestationnel.

L'électroencéphalogramme, l'imagerie cérébrale, surtout l'IRM et l'échographie transfrontalellaire et l'examen du fond d'œil. En gros, le prématuré ressemble à un bébé qui respire vite, qui est plus rapide, qui a une petite taille, qui est harmonieux, qui est plus faible dans son poids, qui a une carthoracique étroite avec une peau fine, rosée avec un lacis veineux sous-cutané, un paniculadip très mince, des oreilles mal ourlées, un cartilage et des oreilles moues, les pluies plantaires qui sont effacées, une hypotonie, une faible réactivité. Les organes génitaux externes chez les petits garçons trouvent des testicules qui ne sont pas descendues, un crotone non-twisté et chez la petite fille, des grandes lèvres bien séparées avec la protrusion des petites lèvres.

Les scores de maturation morphologique et neurologique sont utilisés quand l'âge gestationnel n'est pas connu avec précision. Le prématuré présente beaucoup de complications. Nous devons

les connaître afin de les prévenir et de les traiter.

La première des complications la plus fréquente, c'est l'hypothermie. Elle doit être prévenue par un certain nombre de mesures. D'abord avant la naissance, en préparant la salle de naissance.

Et puis juste après la naissance, on doit le sécher par un linge propre sec et chaud. Parfois par des sacs spéciaux qui diminuent la déperdition thermique. Et après la naissance, si le bébé est hospitalisé, on doit le mettre dans un infubateur à température adéquate et limiter dans la mesure du possible la déperdition thermique.

Parmi les autres complications métaboliques, nous retrouvons l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, l'hyponatrémie qui est expliquée par une extrême immaturité tubulaire. Et donc, le nouveau-né perd beaucoup de sel, ce qui se traduit par une hyponatrémie. Par conséquent, il y a une hypercadémie qui en résulte et qui risque d'entraîner une arrhythmie cardiaque.

Donc, il faut monitorer les quotations égales. Parmi les complications respiratoires, nous en avons plusieurs. La première des choses, c'est la maladie de membranialisme qui se retrouve le plus souvent chez les prématurés de moins de 34 semaines et qui est une pathologie résultante d'un défaut de surfactant.

Son traitement repose sur la prise en charge par le surfactant exogène par voie endotrachéale. Parfois, une assistance respiratoire est importante afin de dépasser le cap des maladies de membranialisme. Nous pouvons avoir cette assistance respiratoire soit une ventilation assistée ou bien une ventilation non invasive, c'est-à-dire la CIPA.

La prévention dans la maladie de membranialisme est la plus importante. Elle repose sur la corticothérapie avant la naissance chez la maman. Les apnées sont également une des complications respiratoires les plus importantes, les plus fréquentes.

Une apnée est définie par l'arrêt de mouvement respiratoire de plus de 20 secondes ou bien arrêt de mouvement respiratoire avec bradycardie et ou désaturation à moins de 85%. Le traitement repose sur les moyens non médicamenteux, tels que les décubitus ventrales, les stimulations tactiles ou bien la pression positive nasale ou bien sur des traitements médicamenteux tels que la caféine. Parmi les complications respiratoires, il y a également les anomalies de résorption des liquides pulmonaires, dits décrets respiratoires transitoires ou étoiles, d'autant plus fréquentes que la gestationnelle est basse.

L'amélioration est en général rapide entre 2 à 3 jours. Et la radiothorax permet de retrouver une diminution de la transparence pulmonaire avec un syndrome interstitiel et un pouvoir qui est compliant. Donc le mothorax est également une complication très fréquente chez les prélatés.

Nous arrivons aux complications neurologiques. Les hémorragies intraventriculaires, ce sont des hémorragies qui naissent dans la zone urinaire sous le tendymaire, dans le plancher du

ventricule latéral et qui peuvent s'étendre et qui obéissent à une stagification allant du stade 1 jusqu'au stade 4. Le stade 1 a un pronostic qui est très bon, le stade 4 a un pronostic fâché. Voici un exemple d'une hémorragie grade 4. La leucomalacie périventriculaire est liée à une myélinocytose de la substance blanche périventriculaire.

Ayant comme principale cause les apnées réprématurées. Ainsi, l'échographie transfrontalinale est systématique. Dès la naissance, elle permet de dépister certaines lésions de cette leucomalacie périventriculaire.

Le pronostic est en général fâché. L'IRM cérébrale pose le diagnostic d'une façon certaine. Parmi les complications neurologiques de l'arrhythmopathie des prématurés.

Les complications digestives sont représentées par l'entéroptose ou sur une érosion. Elle est grave, elle touche 1 à 3 % des prématurés hospitalisés. Elle correspond à une microcéphalie d'appareil intestinal.

Si on fait un ASP, on trouve un aspect de pneumotose radiologique. Parmi les complications hémodynamiques, on retrouve l'impéccance du canal artériel. Qui peut entraîner une insuffisance cardiaque chez les prématurés.

Et un risque d'hémorragie intra-alvéolaire. Le traitement repose sur la restriction hydrique. Ainsi que l'ulitrophène ou l'indométacine injectables.

La deuxième complication hémodynamique est représentée par l'hypotension artérielle. Il est donc très important de monitorer régulièrement la tension artérielle chez les nouveaux-nés prématurés. Les autres complications sont représentées par le nucléaire.

Avec un risque de faire un nucléaire nucléaire beaucoup plus important chez les prématurés. Le prématuré fait également beaucoup d'années nues. Par l'insuffisance de l'erythropoïdine.

Il fait des océopénies qui sont l'équivalent d'un rachitisme. Et il est très exposé à faire des infections et des sepsis. Il est très important d'observer les règles d'asepsie très rigoureuses lors des soins du nouveau-né prématuré hospitalier.

Le nouveau-né prématuré a, à côté des besoins médicaux qu'on lui prodigue, besoin de soins de développement. Ces mesures reposent sur la promotion de l'allaitement maternel qui est indiscutable dans la prise en charge du nouveau-né prématuré. Les soins kangourous, le cœur à cœur ou peau à peau.

Les soins individualisés dits unités CAP. Dans la mesure du possible, on fait un rassemblement familial, mère-enfant. Le soutien psychologique est très important aux parents.

Il y a certains soins lui prodigués tels que les massages, la musicothérapie en fonction de la demande des parents. Concernant le devenir du prématuré, la mortalité augmente au fur et à

mesure que l'âge gestationnel est bas. La morbidité suit la même évolution.

Parmi les séquelles neurosensorielles qu'on retrouve chez le prématuré, l'infirmité motrice d'origine cérébrale, la cécité, la surdité, les troubles de comportement ainsi que les difficultés scolaires. La dysplasie broncopulmonaire est étroitement liée à l'âge gestationnel. Je vous remercie.